Boletín Epidemiológico N° 46 de 2025

Dirección de Vigilancia de la Salud

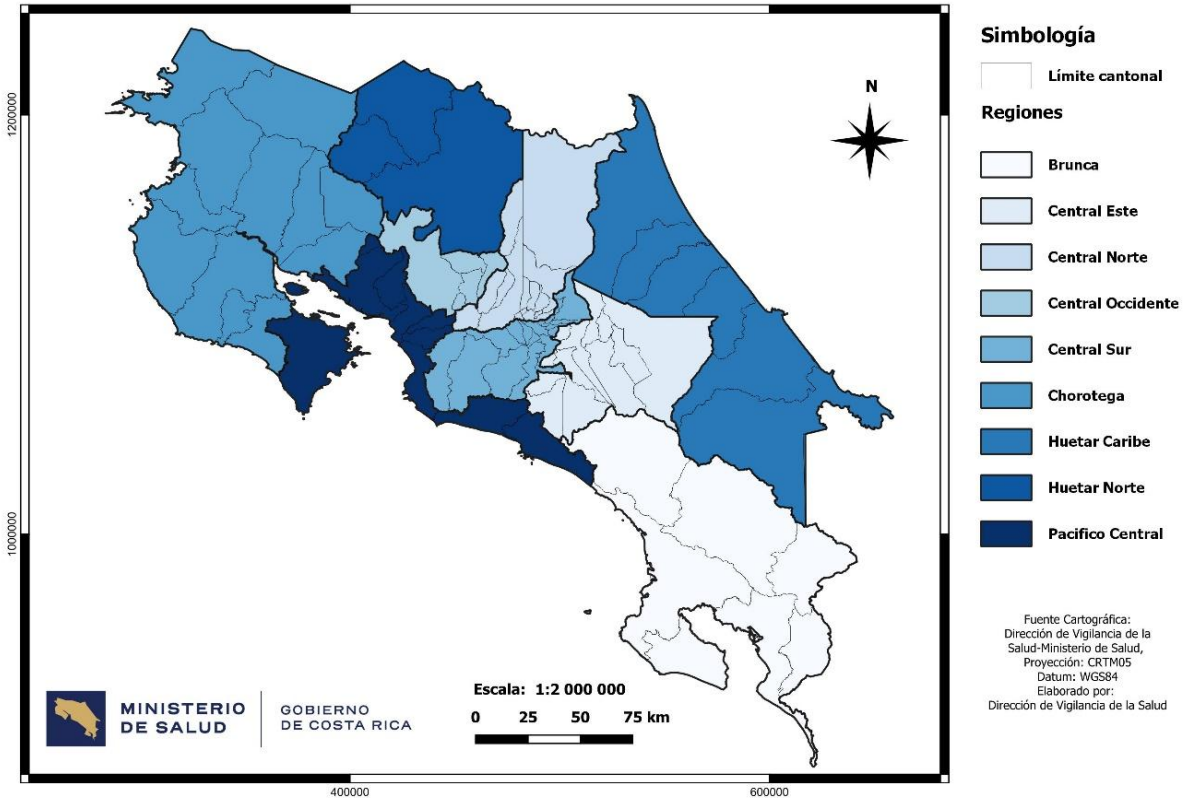
Ministerio de Salud

5 de diciembre de 2025

Tabla de contenido

Arbovirosis 3
Control vectorial realizado en el país a la semana epidemiológica 47 6
Malaria 7
Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) 11
Meningitis 15
Infecciones de transmisión sexual 18
Miasis por gusano barrenador en humanos 26

Costa Rica. Regionalización Ministerio de Salud, 2024



Arbovirosis

Dengue

A la semana epidemiológica 47 del año 2025 se notifican **5236 casos** de dengue, de estos 57 acumulados notificados con signos de alarma.

En la región Central Sur se concentra la mayor notificación acumulada con 2135 casos y la tasa más alta en la Pacífico Central 232,2/100.000 habitantes.

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos y tasas de dengue por región a la semana epidemiológica 47, 2025 (Tasa por 100.000 hab.)

Región	Casos	Tasa
Central Sur	2135	141,5
Chorotega	864	183,5
Pacifico Central	723	232,2
Central Norte	638	60,9
Huetar Caribe	272	59,7
Brunca	250	70,8
Central Este	164	29,7
Huetar Norte	126	46,8
Central Occidente	64	28,7
Total	5236	100,9

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

En la tabla 2 se pueden observar los casos notificados por provincia y sexo para el año 2025.

Cuadro 2.
Costa Rica: casos de dengue notificados por provincia y sexo, 2025

Provincia	Total casos	Tasa	Femenino	Tasa	Masculino	Tasa
San José	2181	131,2	1178	139,7	1003	122,5
Puntarenas	884	174,8	407	162,8	477	186,6
Guanacaste	861	208,1	385	187,7	476	228,2
Alajuela	678	63,1	354	66,0	324	60,1
Limón	272	59,7	123	55,2	149	63,9
Heredia	192	35,1	95	34,6	97	35,7
Cartago	168	31,5	74	27,6	94	35,5
Total	**5236**	**100,9**	**2616**	**100,6**	**2620**	**101,1**

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud.

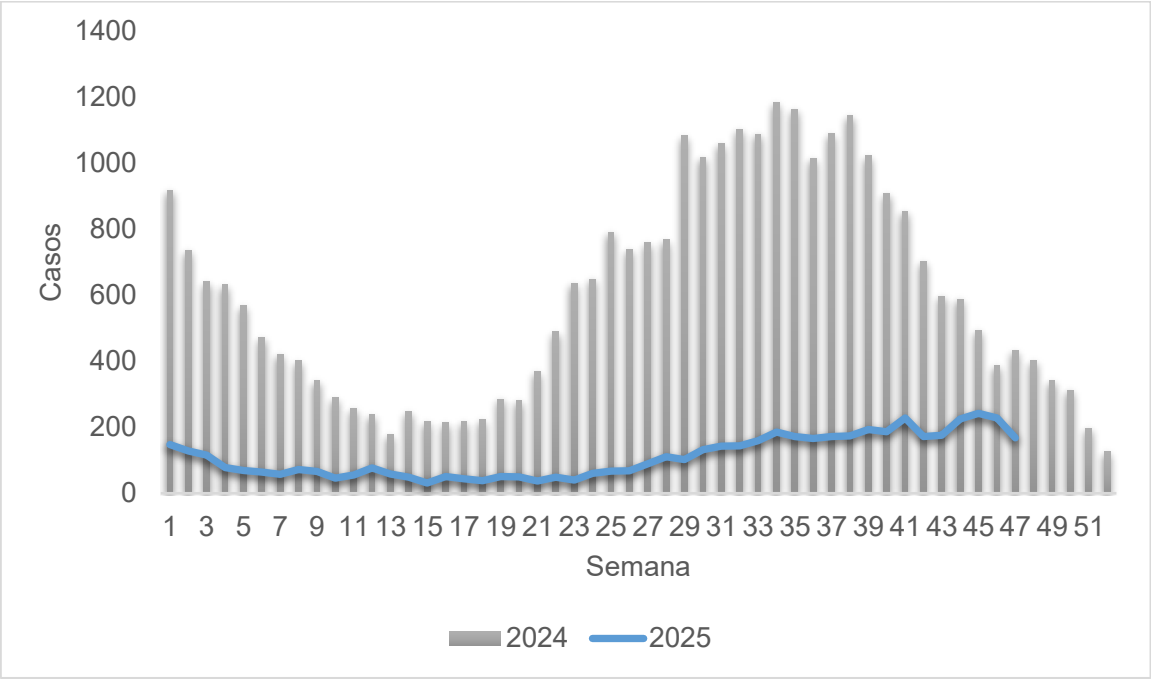
Los cantones con mayor número de casos acumulados a la semana epidemiológica 47 son: San José 1392 casos, Alajuela 360 casos, Puntarenas 305 casos, Carrillo 269, Alajuelita 253 casos.

Cuadro 3.
Costa Rica: cantones prioritarios de dengue por tasa/100.00 habitantes a la semana epidemiológica 47, 2025.

Cantón	Casos	Tasa
604: Montes de Oro	81	541,3
505: Carrillo	269	539,4
602: Esparza	185	521,1
101: San José	1392	394,1
510: La Cruz	93	331,4
605: Osa	82	278,3
110: Alajuelita	253	259,6
503: Santa Cruz	170	232,1
601: Puntarenas	305	211,2
501: Liberia	146	178,7
109: Santa Ana	107	172,2
201: Alajuela	360	109,8
702: Pococí	86	55,1
103: Desamparados	111	45,3
210: San Carlos	85	40,1

Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

Gráfico 1.
Costa Rica: casos de dengue a la semana epidemiológica 47, 2024-2025.



Fuente: Dirección de Vigilancia de la Salud

La Gerencia Médica, Área de Estadística en Salud según los datos recopilados mediante EDUS reporta al 1 de diciembre cuatro personas hospitalizadas: 1 en el Hospital Víctor Manuel Sanabria, 1 Hospital Enrique Baltodano, 1 en el Hospital San Juan de Dios y 1 en el Hospital San Carlos.

Control vectorial realizado en el país a la semana epidemiológica 47

En la siguiente tabla se desglosa el control vectorial que se ha realizado en la semana epidemiológica 47 del 2025, por el personal de Control de Vectores del país.

Cuadro 1.
Costa Rica: Control vectorial realizado en la semana epidemiológica 47

Control Realizado	Total
Viviendas visitadas	**8.198**
Viviendas positivas	**570**
Depósitos tratados	**36.627**
Depósitos eliminados	**13.067**
Depósitos positivos	**1.066**
Viviendas fumigadas	**11.385**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial.

Cuadro 2.
Costa Rica: Consolidado de control vectorial de semana 1-47 de 2025.

Control Realizado	Total
Viviendas visitadas	**586.442**
Viviendas positivas	**30.173**
Depósitos tratados	**2.138.630**
Depósitos eliminados	**1.440.749**
Depósitos positivos	**52.085**
Viviendas fumigadas	**730.279**

Fuente: Consolidado Nacional de actividades de Control Vectorial

Malaria

Situación de la malaria en Costa Rica: actualización a la semana epidemiológica 47 del 2025

El histórico de transmisión local de malaria en Costa Rica evidencia una tendencia sostenida a la disminución de casos en los últimos tres años. Durante el periodo comprendido entre las semanas epidemiológicas 1 a 47:

- En 2023, se notificaron 489 casos autóctonos.
- En 2024, se registraron 235 casos, lo que representa una disminución del 48 % respecto al mismo periodo del año anterior.
- En lo que va del año 2025, se han reportado de manera preliminar 12 casos autóctonos y 4 casos introducidos (16 de transmisión local), lo que representa una reducción del 97 % en comparación con el mismo periodo del 2023 y 93% con respecto al año 2024.

Esta tendencia positiva refleja el impacto de las intervenciones dirigidas a la interrupción de la transmisión local, especialmente en los focos históricos.

Distribución preliminar de casos de malaria por región de salud y clasificación epidemiológica, Costa Rica, 2025
Durante el año 2025 se notificaron 73 casos de malaria en el país. La distribución según clasificación epidemiológica y región de salud fue la siguiente:

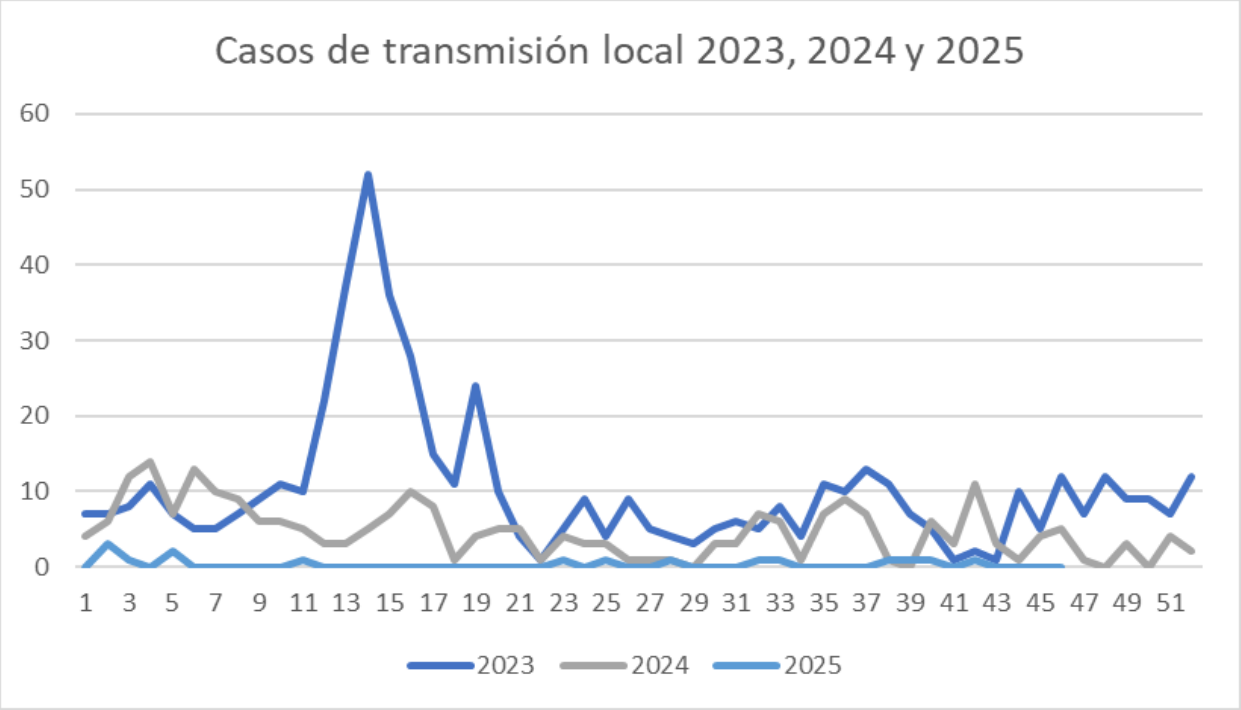
- Región Huetar Caribe: 13 casos
    - 11 casos autóctonos de *Plasmodium falciparum*, localizados en el foco de Matina.
    - 1 caso introducido de *Plasmodium falciparum*, localizado en el foco de Matina.
    - 1 caso importado de *Plasmodium falciparum*, detectado en el foco de Matina.
- Región Huetar Norte: 41 casos
    - 1 caso autóctono de *P. vivax* del foco de Crucitas
    - 3 casos introducidos de *P. vivax* del foco de Crucitas.

- 23 casos importados de *P. vivax* del foco de Crucitas (20) y del foco de los Chiles (3), con nexo con Nicaragua.
- 14 casos en estudio de *P. vivax* del foco de Crucitas

- Otros casos importados: El país ha detectado adicionalmente 18 casos importados (*12 P. vivax, 5 P. falciparum, 1 P. malariae),* en distintas regiones del país, tales como Región Brunca en zonas fronterizas, Región Central Norte, Central Occidente, Central Sur, Chorotega y Pacífico. principalmente como operarios de construcción, peones agrícolas, coligalleros y personas en condición de movilidad humana, provenientes de Nicaragua, de la ruta migratoria desde América del Sur, o en retorno desde África (Gabón, Tanzania, Kenia).

Esta información resalta la importancia de mantener la vigilancia activa, fortalecer los mecanismos de respuesta en zonas de riesgo y asegurar el diagnóstico y tratamiento oportuno, con enfoque especial en poblaciones móviles y zonas de tránsito.

Gráfico 1.
Costa Rica: Comportamiento de casos de transmisión local del año 2023, 2024 y 2025 a SE 47.

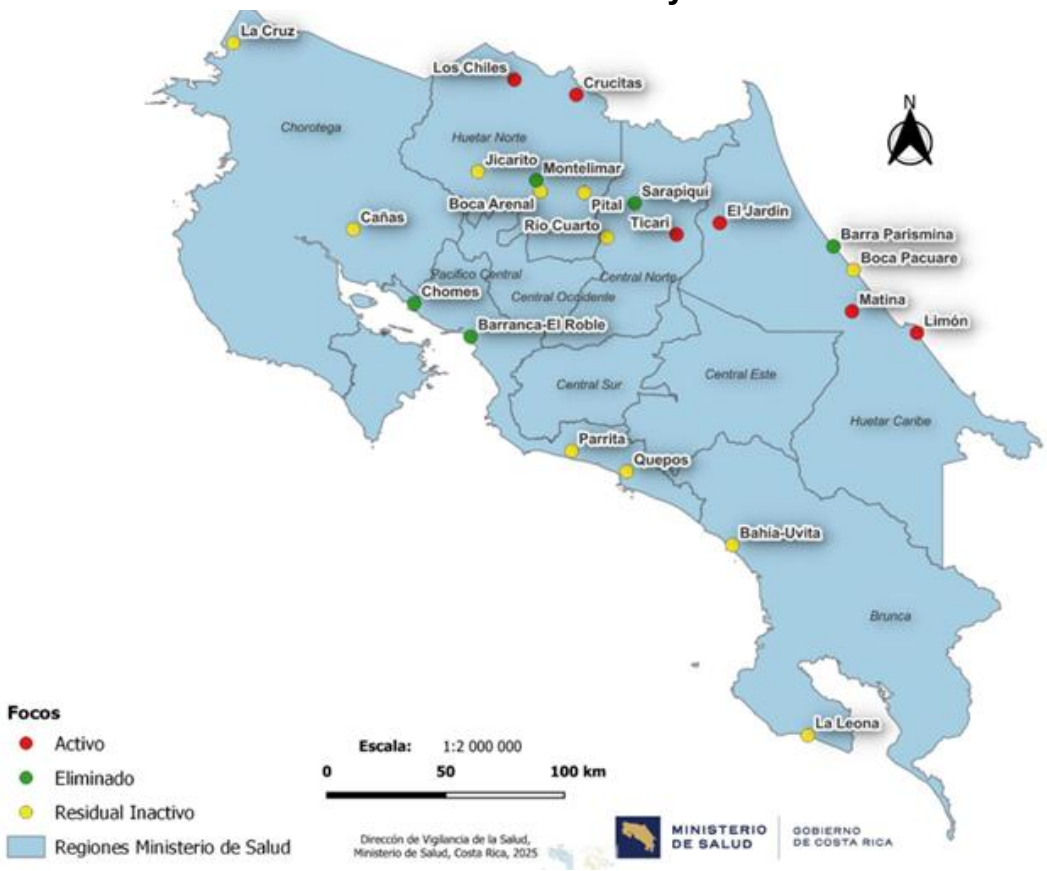


Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Inventario de focos.

En el país se cuenta con un inventario de focos en constante actualización, actualmente se tienen 6 focos activos, 10 focos residuales inactivos y 5 focos eliminados.

Figura 1.
Costa Rica: Inventario de focos de Malaria a mayo 2025.



Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica

Para que un foco sea declarado como residual inactivo debe transcurrir 1 año sin aparición de casos autóctonos, paralelamente, para que un foco sea declarado como eliminado, debe transcurrir 3 años sin transmisión autóctona del parásito.

Cuadro 1.
Costa Rica: Listado de Focos de malaria a Setiembre 2025, por provincia, cantón y estado actual del foco.

Provincia	Cantón	Nombre del Foco	Estado
Alajuela	San Carlos	Pital	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Boca Arenal	Residual inactivo
Alajuela	San Carlos	Monterrey	Eliminado
Alajuela	San Carlos	Crucitas - Llano Verde	Activo
Alajuela	Los Chiles	Los Chiles	Activo
Alajuela	San Carlos	Jicarito	Residual inactivo
Alajuela	Río Cuarto	Rìo Cuarto	Residual inactivo
Guanacaste	La Cruz	La Cruz	Residual inactivo
Guanacaste	Cañas	Cañas	Residual inactivo
Heredia	Sarapiquí	Sarapiquí	Eliminado
Heredia	Sarapiquí	Ticari	Activo
Limón	Matina	Matina	Activo
Limón	Limón	Limón	Activo
Limón	Siquirres	Barra de Parismina	Eliminado
Limón	Pococí	El Jardín	Activo
Limón	Siquirres	Barra Pacuare	Residual inactivo
Puntarenas	Roble	El Roble	Eliminado
Puntarenas	Puntarenas	Chomes	Eliminado
Puntarenas	Quepos	Quepos	Residual inactivo
Puntarenas	Parrita	Parrita	Residual inactivo
Puntarenas	Golfito	La Leona	Residual inactivo
Puntarenas	Osa	Bahia Uvita	Residual inactivo

Fuente: Coordinación de Malaria, Dirección de Vigilancia de la Salud, Ministerio de Salud de Costa Rica.

Situación epidemiológica de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) al 2 de diciembre 2025.

En la semana epidemiológica 47 del año 2025 se reportan 369315 casos acumulados de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). De acuerdo con el comportamiento epidemiológico de este evento, se observa una curva epidémica ubicada en zona de seguridad, con una tasa de incidencia de 6723 casos por cada 100,000 habitantes, calculada con base en la actualización de datos poblacionales estimados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

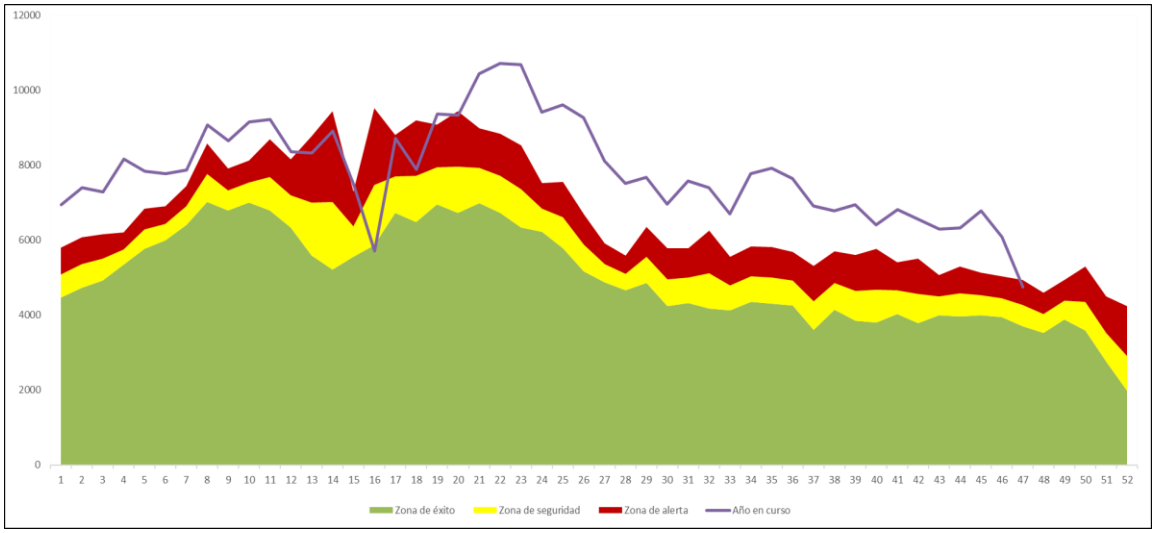
La incidencia de las Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) para la Semana Epidemiológica (SE) 47 del año 2025 refleja una disminución en los casos notificados respecto al mismo periodo del año 2023, lo que muestra una tendencia descendente sostenida a partir de la SE 20, comportamiento que contrasta con el aumento registrado en la misma etapa del 2023.

Durante las primeras 15 semanas del 2025, se observó una tendencia al alza respecto al 2023, con valores significativamente superiores, particularmente entre la SE 8 y SE 14, donde se alcanzaron picos como los 9,603 casos en la SE 10 (vs 6,602 en 2023). No obstante, a partir de la SE 16, esta tendencia comienza a revertirse progresivamente, y para la SE 47 se consolida una predisposición disminuida en la frecuencia de casos.

Este patrón refleja una situación epidémica ubicada en zona de alerta del canal endémico, lo cual coincide con la presencia del fenómeno climático de La Niña, asociado históricamente con un incremento en las lluvias y la humedad, condiciones que pueden favorecer la transmisión de agentes causantes de diarreas. Cabe destacar que en el 2023 se presentó una situación epidemiológica similar también bajo los efectos de La Niña.

Los datos presentados son preliminares y se encuentran en proceso de validación, por lo que podrían surgir ajustes que modifiquen la posición actual en el canal endémico.

Gráfico 1
Costa Rica. Canal endémico para EDA por semana epidemiológica hasta la SE 47. Años 2017- 2025. *



Fuente: Datos preliminares, Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.
*Nota: Se excluyen del 2020 y 2021por la pandemia COVID-19 y 2023 por hackeo de la CCSS.

El canal endémico de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) se clasifica en tres zonas de comportamiento: zona de éxito (verde), zona de seguridad (amarillo) y zona de alerta (rojo), construidas a partir de los promedios y límites históricos esperados. La línea morada representa el comportamiento observado durante el año 2025.

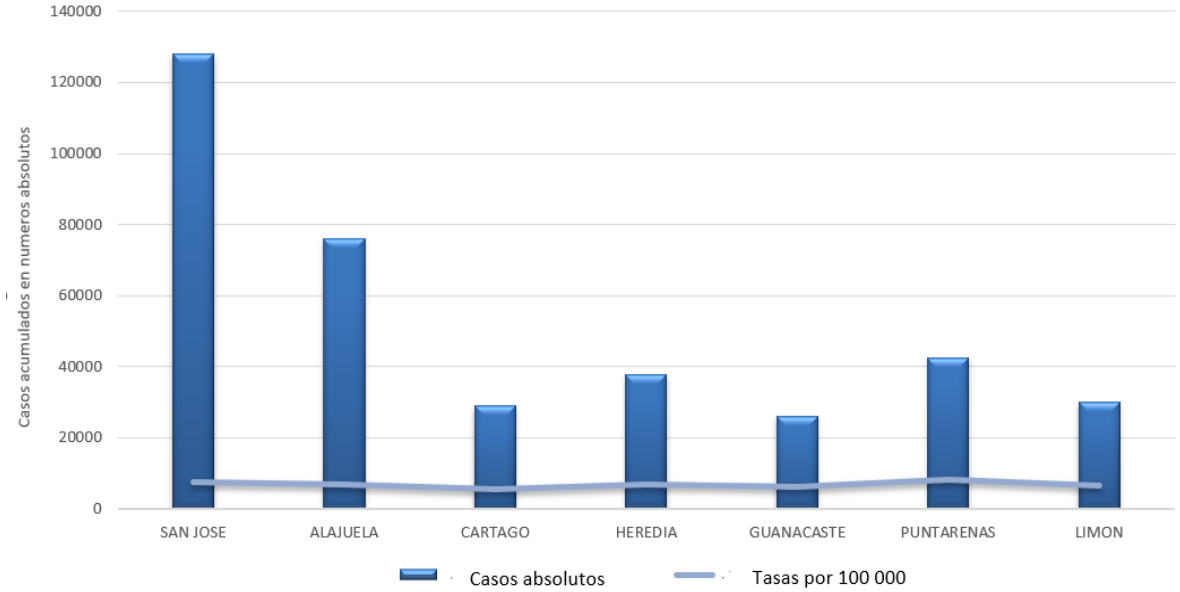
Durante las primeras semanas epidemiológicas (SE 1–7), los casos de EDA se mantuvieron dentro de la zona de éxito, mostrando un comportamiento estable y por debajo del umbral de alerta. A partir de la SE 8, se inicia un ascenso progresivo que ubica la curva en el límite superior de la zona de seguridad, lo que indica un aumento sostenido de la incidencia.

Entre las SE 14 y 24, se observa el periodo de mayor intensidad del año, con un comportamiento que supera de forma constante los límites históricos y se mantiene dentro de la zona de alerta, alcanzando su máximo pico alrededor de la SE 20–22. Este comportamiento sugiere una fase epidémica marcada, caracterizada por un incremento considerable de casos en comparación con los valores esperados.

A partir de la SE 25, la tendencia comienza a descender gradualmente, aunque se mantiene por algunos periodos dentro de la zona de alerta y seguridad. Desde la SE 30 en adelante, el número de casos continúa en disminución sostenida, ubicándose hacia la SE 47 predominantemente en la zona de seguridad. Durante las últimas semanas del año se espera (SE 48–52), que el comportamiento

permanezca dentro de los límites esperados, con valores que oscilan entre las zonas de éxito y seguridad, reflejando un control progresivo de la incidencia.
En síntesis, el comportamiento de EDA en 2025 muestra un ascenso temprano con un pico epidémico a mediados del año, seguido de una disminución constante y estabilización posterior, consistente con un ciclo estacional típico, sin evidencia de repuntes hacia el cierre del periodo analizado.
A la Semana Epidemiológica 47 del 2025, los 15 cantones con las tasas de incidencia más elevadas de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) son: Flores, Vázquez de Coronado, Montes de Oro, Orotina, Puntarenas, Garabito, Santa Cruz, Mora, San José, Alajuelita, Goicochea, Alajuela, Esparza, Nandayure, Cañas.
Estos cantones presentan una incidencia significativamente superior al promedio nacional, destacándose la mayoría por mantener tasas elevadas de manera sostenida a lo largo del primer semestre del año, lo que sugiere una persistencia del riesgo epidemiológico en estos territorios, o una mejor notificación de estos eventos en los servicios de salud.
Las Regiones Rectoras con más casos son: Pacifico Central, Central Norte, Central Sur. El grupo de edad más afectado es el de adultos de 20 a 39 años.

Gráfico 2
Costa Rica. Incidencia de casos de EDA, según provincia. SE 47, 2025.



Fuente: Datos preliminares. Dirección Vigilancia de la Salud. Ministerio de Salud.

Este comportamiento regional resalta la necesidad de prevenir y controlar las zonas con mayor incidencia relativa y carga acumulada, particularmente en las regiones Central Sur, Central Norte y Pacífico Central.

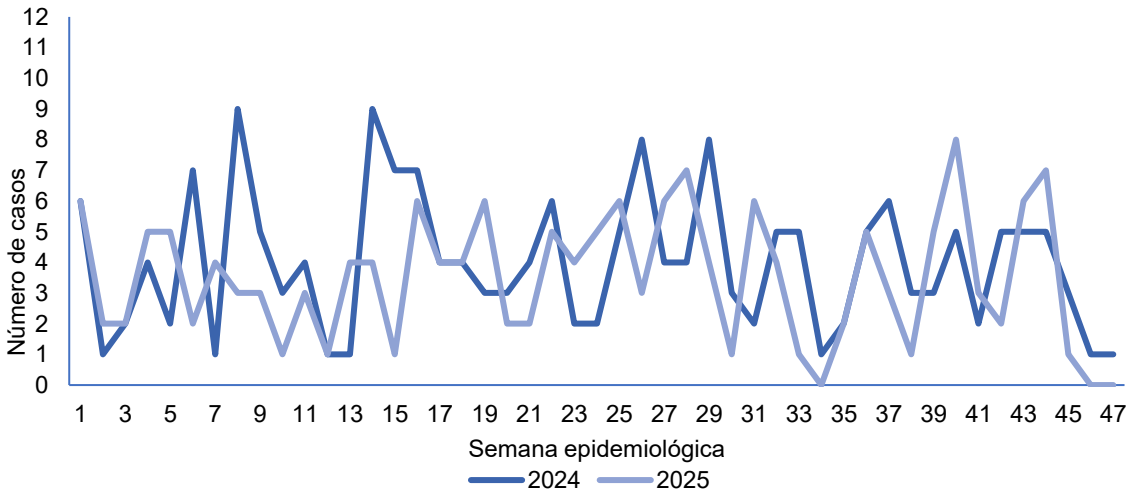
Es esencial el cumplimiento del protocolo de lavado de manos, así como la promoción de adecuadas prácticas de higiene personal, manipulación segura de alimentos y correcta cocción de estos. Estas medidas resultan fundamentales ante el incremento sostenido en los casos de diarrea aguda reportados por el sistema de salud, tanto de origen viral como bacteriano, los cuales superan el comportamiento esperado para esta época del año.

En este contexto, cobra especial relevancia la aplicación rigurosa del Protocolo de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, para la investigación oportuna de los casos y brotes, incluyendo el uso de flujogramas para abordar distintas etiologías probables. Las actividades de vigilancia activa, investigación de campo y respuesta inmediata ante alertas locales es clave para contener la transmisión, identificar factores de riesgo y reducir la carga de enfermedad en las comunidades más afectadas.

Meningitis

La meningitis es una peligrosa inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, causada principalmente por una infección bacteriana o vírica.
La meningitis causada por una infección bacteriana suele ser la más grave que provoca unas 250,000 muertes por año y posibles epidemias de rápida propagación. Ocasiona la muerte de una de cada diez personas infectadas, en su mayoría niños y jóvenes y deja a una de cada cinco con discapacidades duraderas, como convulsiones, pérdida de audición y visión, daños neurológicos y deterioro cognitivo.
En Costa Rica, hasta la semana epidemiológica 46 del año 2025, se han registrado 165 casos sospechosos de meningitis reportados mediante boleta VE01, lo que representa una tasa de incidencia de 3,1 por cada 100.000 habitantes. En comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 188 casos, se observa una disminución del 12,2% sin que se reporten brotes para esta semana.
De las 9 Regiones del Ministerio de Salud, la Región Central Este y la Central Norte tienen la mayor cantidad de casos con un 21,8% respectivamente (36/165) seguido de la Región Central Sur con 20,0% (33/165).

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos sospechosos de meningitis comparativa año 2024 con el 2025 a la semana epidemiológica 46, 2025



Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud

En la siguiente tabla se presentan los 15 cantones con las tasas más elevadas de meningitis. León Cortés registra la mayor tasa con un 14,0 por 100 000 habitantes, seguido por Turrubares con 13,8 y Dota con 12,2; los tres pertenecen a la provincia de San José.

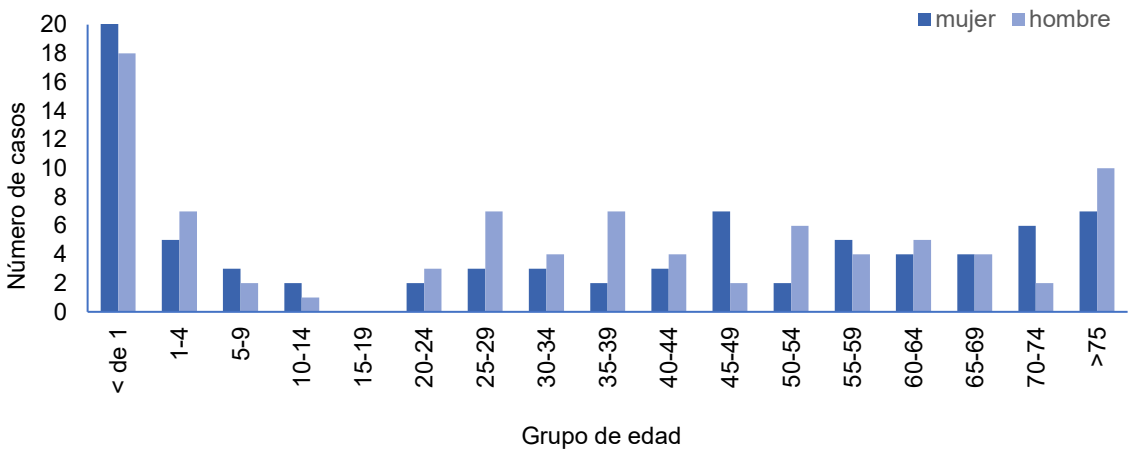
Gráfico 2.
Costa Rica: Casos notificados de meningitis según 15 cantones prioritarios, acumulado a la semana epidemiológica 46, 2025 (tasa p/100.000 habitantes)

Cantón	Casos	Tasa
León Cortes	2	14,0
Turrubares	1	13,8
Dota	1	12,2
Hojancha	1	12,2
Flores	3	11,5
Osa	3	9,5
Santa Barbara	4	8,8
Cañas	3	8,7
Turrialba	6	8,2
Cartago	13	7,7
Bagaces	2	7,7
Sarapiquí	7	7,4
Pérez Zeledón	10	7,0
Santa Cruz	5	6,7
Montes de Oro	1	6,7

Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

La figura 3 presenta la distribución de los casos sospechosos según sexo y grupo de edad. En la semana analizada, se observa una distribución por sexo, con un 52,1% de los casos (86/165) en hombres y un 47,8% (79/165) en mujeres. El 23,6% de los casos (39/165) son menores de 1 año

Gráfico 3.
Costa Rica: Casos notificados por meningitis según sexo y edad, a la semana epidemiológica 46, 2025



Fuente: Ministerio de Salud-Dirección de Vigilancia de la Salud. Unidad de Indicadores de la Salud.

Infecciones de transmisión sexual

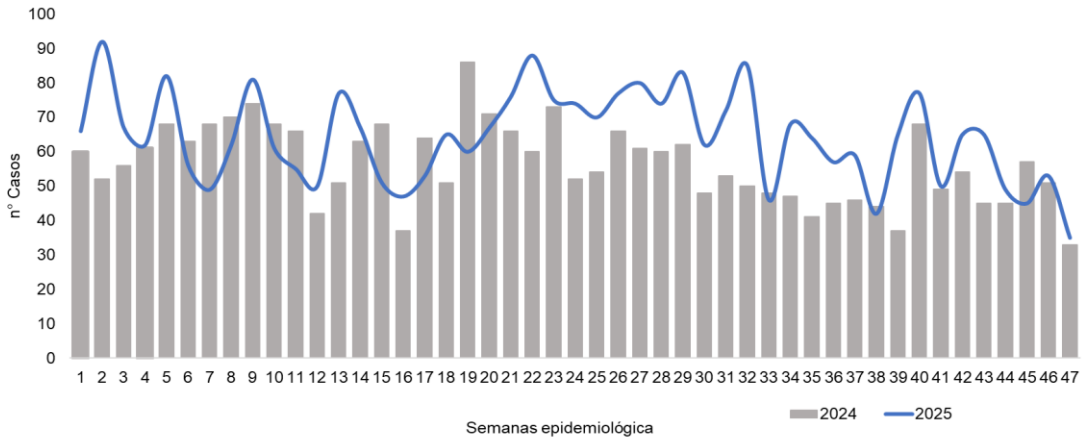
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son de notificación obligatoria, conforme al Reglamento de Vigilancia de la Salud N.º 40556-S. Por lo tanto, su vigilancia semanal constituye un componente esencial para la salud pública del país.

Durante las semanas epidemiológicas 1 a la 47 del año 2025, se han reportado las siguientes ITS, enfermedades de sífilis en todas sus formas, gonorrea y infección por el virus del herpes simple (VHS).

La sífilis en todas sus formas es una enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria *Treponema pallidum*. Es completamente prevenible mediante el uso adecuado del condón y cuenta con tratamiento efectivo. Esta infección se transmite principalmente a través de relaciones sexuales sin protección, así como de madre al hijo durante el embarazo. Debido a su impacto en la salud materno-infantil y en la población general, la sífilis representa un factor importante en la morbilidad.

Durante las semanas 1 a 47 del año 2025, se han notificado 3.026 casos, lo que representa una tasa de 58,30 por cada 100.000 habitantes. En el mismo periodo del año 2024 se reportaron 2.654 casos, evidenciando un incremento del 14,01 % en 2025 equivalente a un incremento de 372 casos. En el Gráfico 1 se presentan los datos distribuidos, según el reporte semanal.

Gráfico 1.
Costa Rica: Casos confirmados por sífilis en todas sus formas, según fecha de inicio de síntomas en el reporte semanal, en los años 2024 y 2025

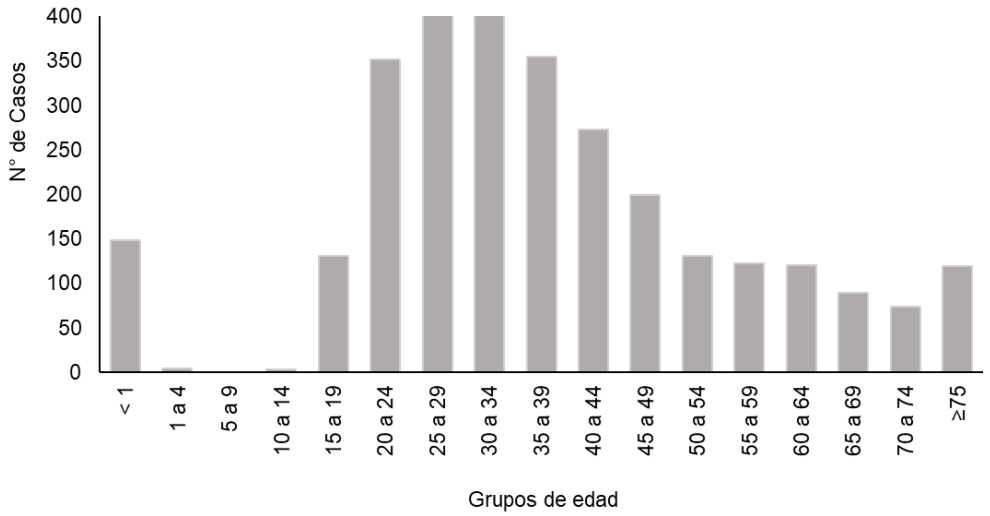


Nota: Datos preliminares, sujetos a ser actualizados.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

El comportamiento epidemiológico de esta enfermedad durante las semanas 1 a 47 del año en curso, muestra un reporte mayor en los hombres con el 60,44% de los casos (1.829 de 3.026) con una tasa de 70,60 por cada 100.000 habitantes. En mujeres, se reportó el 39,56% de los casos (1.197 de 3.026), con una tasa de 46,00 por cada 100.000 habitantes.

Los casos notificados se concentran principalmente en el grupo de edad de 20 a 64 años, que representa el 81,10 % (2.454 de 3.026) de los casos. Le siguen las personas mayores de 65 años con el 9,4 % con 284 de los casos, el grupo de 15 a 19 años con el 4,3 % con 131 casos, en los menores de 1 año con el 4,9 % con 149 casos. En los grupos de 1 a 4 años con cinco casos, el grupo de 5 a 9 años sin casos y el grupo de 10 a 14 años con 3 casos, ver gráfico 2.

Gráfico 2.
Costa Rica: Casos de sífilis en todas sus formas, por grupos de edad en número absoluto, en semana 47 del 2025



Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 1, se presenta el comportamiento de esta enfermedad, según provincias,

Cuadro 1.
Costa Rica: Casos notificados de sífilis en todas sus formas según provincias de procedencia. Números absolutos. (Tasa p/100.000 habitantes), en semana 47 del 2025

Provincias	Nº	Tasa
San José	1213	73,0
Alajuela	435	40,5
Cartago	372	69,8
Heredia	242	44,3
Guanacaste	130	31,4
Puntarenas	220	43,5
Limón	414	90,8
Total	3026	58,30

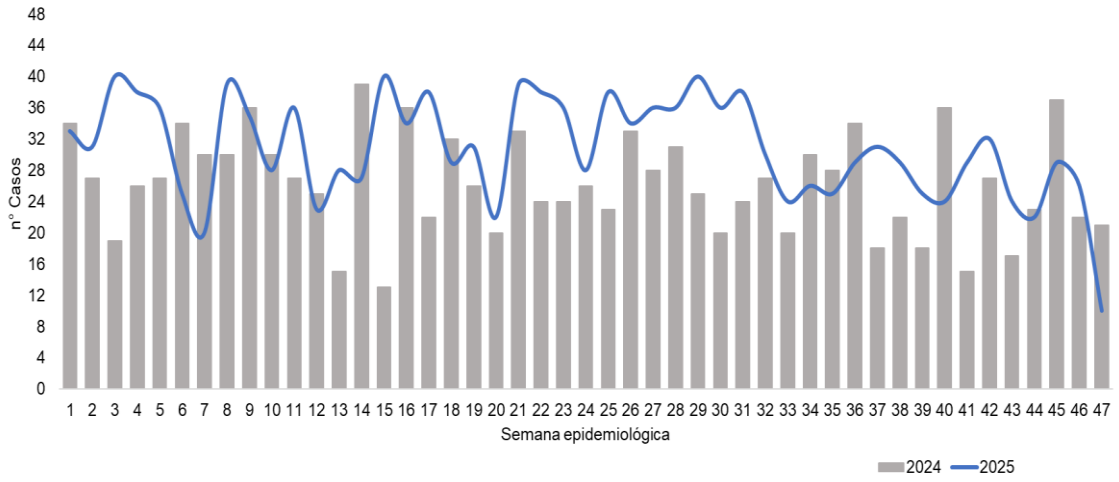
Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Infección por gonorrea

La enfermedad causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*, es completamente prevenible mediante el uso correcto del condón y es una enfermedad tratable. Se transmite principalmente a través de relaciones sexuales sin protección, así como de madre al hijo durante el parto. Debido a su impacto en la salud pública, esta infección contribuye significativamente a la morbilidad del país.

Durante las semanas epidemiológicas 1 a 47 del año 2025, se han notificado 1.447 casos, lo que representa una tasa de 27,90 por cada 100.000 habitantes. En el mismo periodo de 2024 se reportaron 1.234 casos, evidenciando un incremento del 17,26% en el 2025, con un incremento de 213 casos. En el gráfico 3, se presentan los datos distribuidos por semana epidemiológica, lo que permite visualizar la evolución del comportamiento de la enfermedad.

Gráfico 3
Costa Ric3: Casos notificados por gonorrea, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años años 2024 y 2025

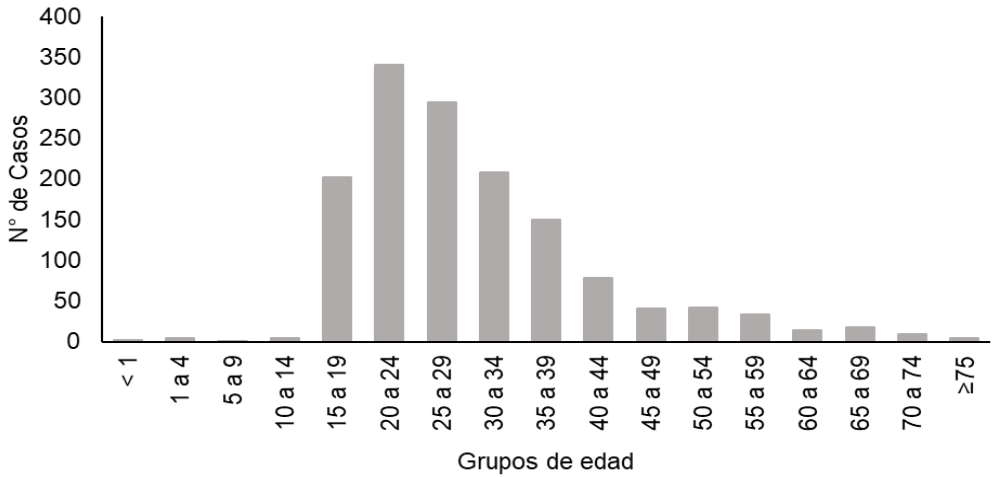


Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Durante las semanas 1 a 47 del año 2025, el comportamiento de esta enfermedad muestra un marcado predominio en hombres, quienes representan el 86,11% de los casos (1.246 de 1.447), con una tasa de 48,10 por cada 100.000 habitantes. En contraste, las mujeres concentran el 13,89% de los casos (201 de 1.447), con una tasa de 7,70 por cada 100.000 habitantes.

La distribución de los casos notificados por grupos de edad hasta las 47 semanas del año 2025 muestra que el mayor porcentaje corresponde al grupo de 20 a 64 años, con un 82,93% (1.200 de 1.447) de los casos. Le sigue el grupo de 15 a 19 años con un 13,96% con 202 de los casos y los mayores de 65 años con un 2,21% con 32 casos. Además, en los menores de 1 años se reportaron dos casos, en menores de 1 a 4 año cinco casos, en el grupo de 5 a 9 años un caso y el grupo de 10 a 14 años con cinco casos, ver gráfico 4.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos de gonorrea por grupos de edad número absoluto, en semana 47 del 2025



Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 2, se presentan el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 2
Costa Rica: Casos notificados por gonorrea, según provincia.
Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 47 del 2025

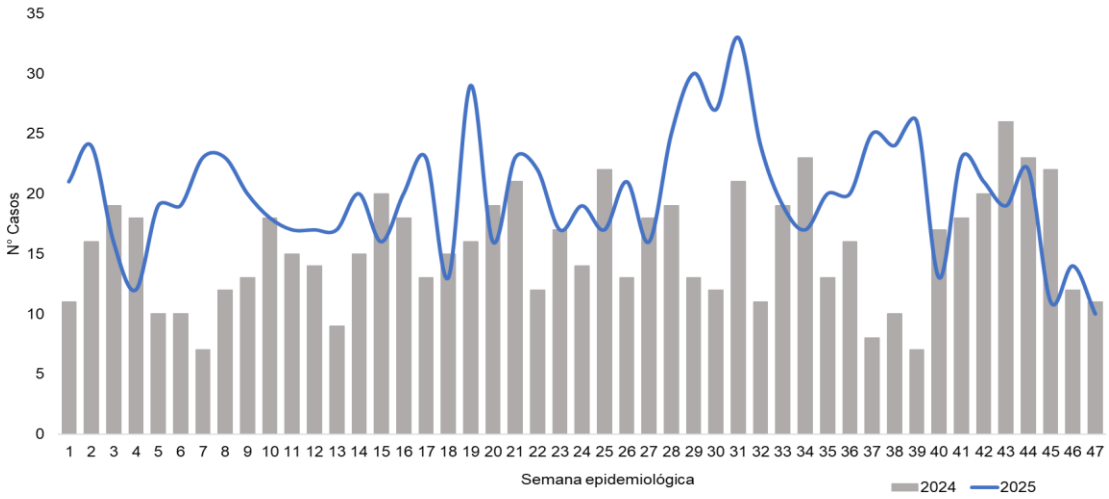
Provincias	Casos	Tasa
San José	593	35,7
Alajuela	205	19,1
Cartago	126	23,6
Heredia	130	23,8
Guanacaste	77	18,6
Puntarenas	146	28,9
Limón	170	37,3
Total	1447	27,90

Nota: Datos preliminares sujetos a revisión.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

Infección por el virus del herpes simple (VHS)

El VHS es otra infección de transmisión sexual que ha sido reportada durante las semanas 1 a 47 del año en curso. En este periodo se registraron 941 casos con una tasa de 18,10 por cada 100.000 habitantes. En comparación al año 2024 se contabilizaron 726 casos, lo que evidencia un incremento del 29,61% en 2025, equivalente a 215 casos adicionales. En el gráfico 3, se presenta el comportamiento semanal de los casos reportados.

Gráfico 5.
Costa Rica: Casos notificados por el virus del herpes, según reporte semanal por fecha de inicio de síntomas, en los años 2024 y 2025

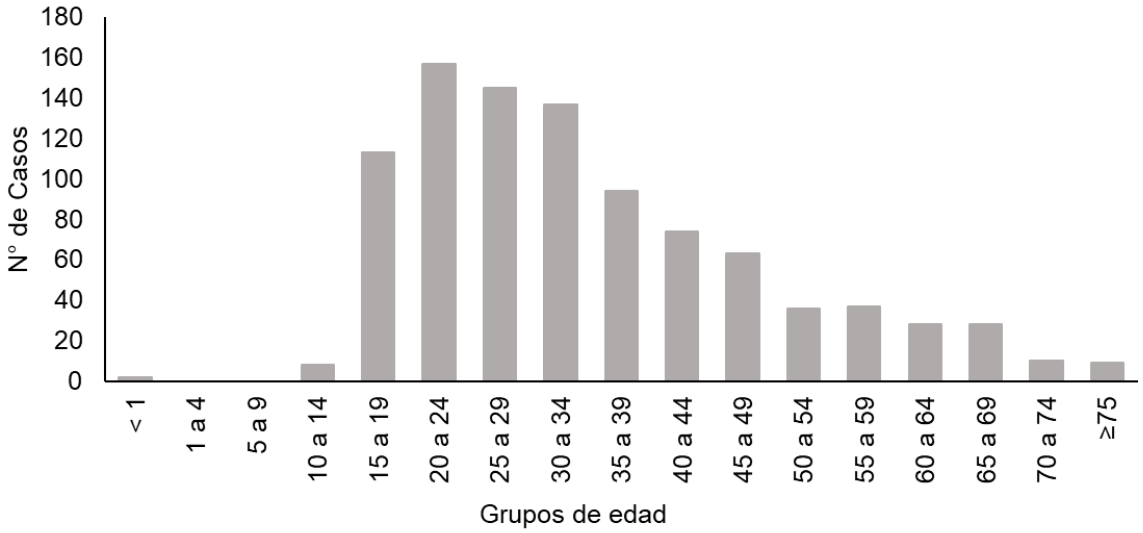


Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

A lo largo de las primeras 47 semanas del año 2025, el comportamiento del virus del herpes muestra una mayor afectación en mujeres, quienes representan el 66,63% de los casos (627 de 941), con una tasa de 24,10 por cada 100.000 habitantes. En los hombres se reportó el 33,37% de los casos (314 de 941), con una tasa de 12,10 por cada 100.000 habitantes.

La distribución de los casos notificados por grupos de edad durante las primeras 47 semanas del año 2025, se muestra que el grupo de 20 a 64 años concentra el mayor número de reportes, con un 81,93% de los casos (771 de 941). Le sigue el grupo de 15 a 19 años con un 12,01% con 113 casos, y los mayores de 65 años con un 4,99% con 47 casos. Además, en menores de 1 año se reportan dos casos, en el grupo de 10 a 14 años ocho casos y en los otros grupos no reportaron casos durante este periodo. Esta información se detalla en el gráfico 6.

Gráfico 6.
Costa Rica: Casos de virus del herpes, por grupos de edad en número absoluto, en semana 47 del 2025



Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

En el cuadro 6, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las siete provincias del país.

Cuadro 3
Costa Rica: Casos notificados por virus del herpes, según provincias. Número absoluto y tasa. Tasa por 100,000 habitantes, en semana 47 del 2025

Provincias	Casos	Tasa
San José	490	29,5
Alajuela	100	9,3
Cartago	62	11,6
Heredia	60	11
Guanacaste	25	6,0
Puntarenas	118	23,3
Limón	86	18,9
Total	941	18,10

Nota: Datos preliminares.
Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS. / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025.

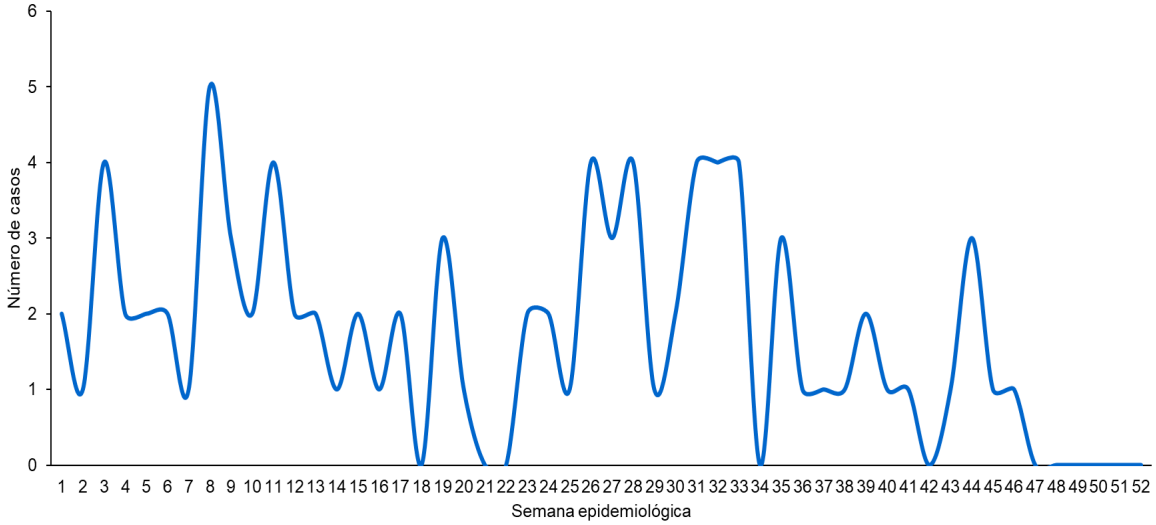
Miasis por gusano barrenador en humanos

A continuación, se presentan los datos de miasis por gusano barrenador en humanos para la semana epidemiológica (SE) 48 del año 2025, según establece el Reglamento de Vigilancia de la Salud Decreto N°40556-S y el Lineamiento Nacional para la Vigilancia de Miasis por Gusano Barrenador en Humanos es un evento de notificación obligatoria al Ministerio de Salud.

En relación con la notificación de esta miasis, por medio de la boleta VE-01, para el año 2025 a la SE 48, se tienen los siguientes datos:

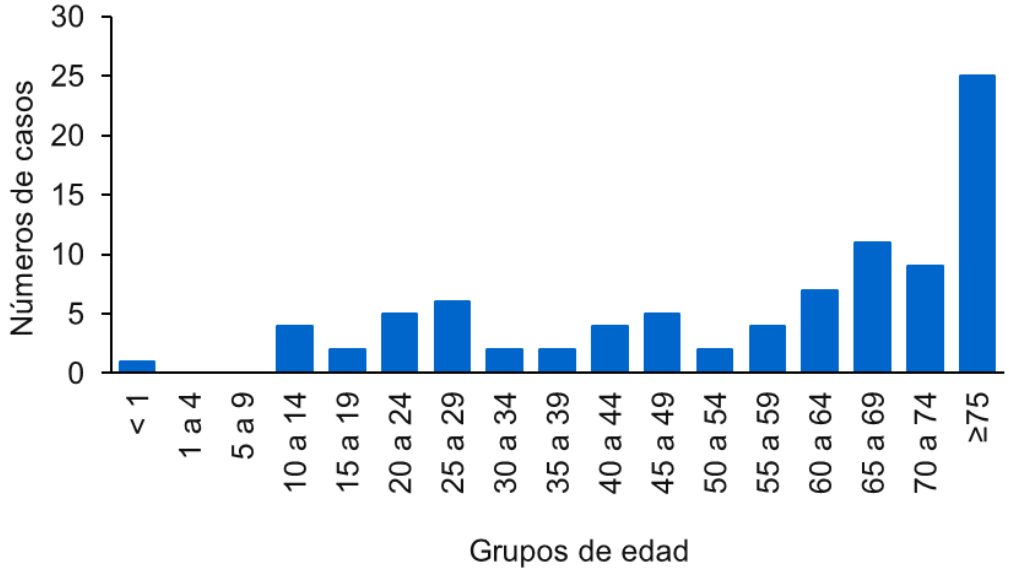
- Casos acumulados de miasis por gusano barrenado en humanos suman un total de 89 casos
- Casos por grupos de edad quinquenal tienen un predominio en las personas de 20 a 64 años (37/89) y las adultas de 65 y más años con más casos reportados (45/89)

Gráfico 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador según SE de la 01 a la 48, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

Gráfico 2
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador según grupos de edad quinquenal, de la SE 01 a la 48, 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

El comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos, en el año 2025, presenta un predominio en los hombres con 62 casos notificados con una tasa de 2,4 por 100.000 habitantes y en las mujeres con 27 casos notificados con una tasa de 1,0 por 100.000 habitantes.

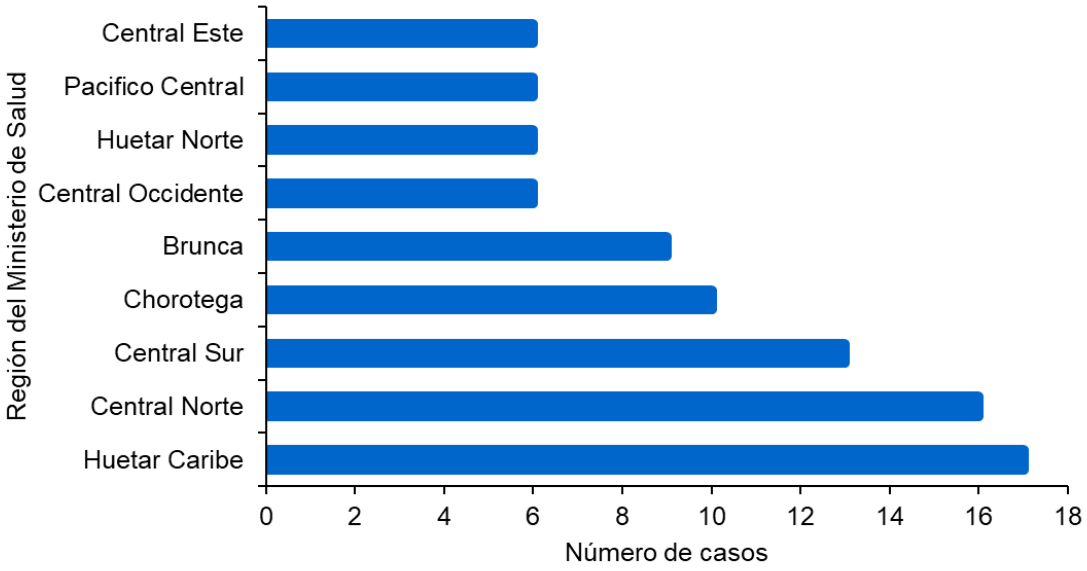
Cuadro 1
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos y tasas (tasa p/100.000 habitantes) según provincia de procedencia, de la SE 01 a 48, 2025

Provincias	Casos	Tasas
Total	**89**	**1,7**
San José	17	1,0
Alajuela	21	2,0
Cartago	5	0,9
Heredia	10	1,8
Guanacaste	9	2,2
Puntarenas	10	2,0
Limón	17	3,7

Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el cuadro 1, se presenta el comportamiento de esta enfermedad por número de casos notificados a la SE 48 según provincia de procedencia, presentando mayor número de casos la provincia de Alajuela (21/89) seguido por la provincia de San José (17/89) y Limón (17/89).

Gráfico 3
Costa Rica: Casos notificados de miasis por gusano barrenador por número de casos según región del Ministerio de Salud de procedencia, de la SE 01 a 48, 2025

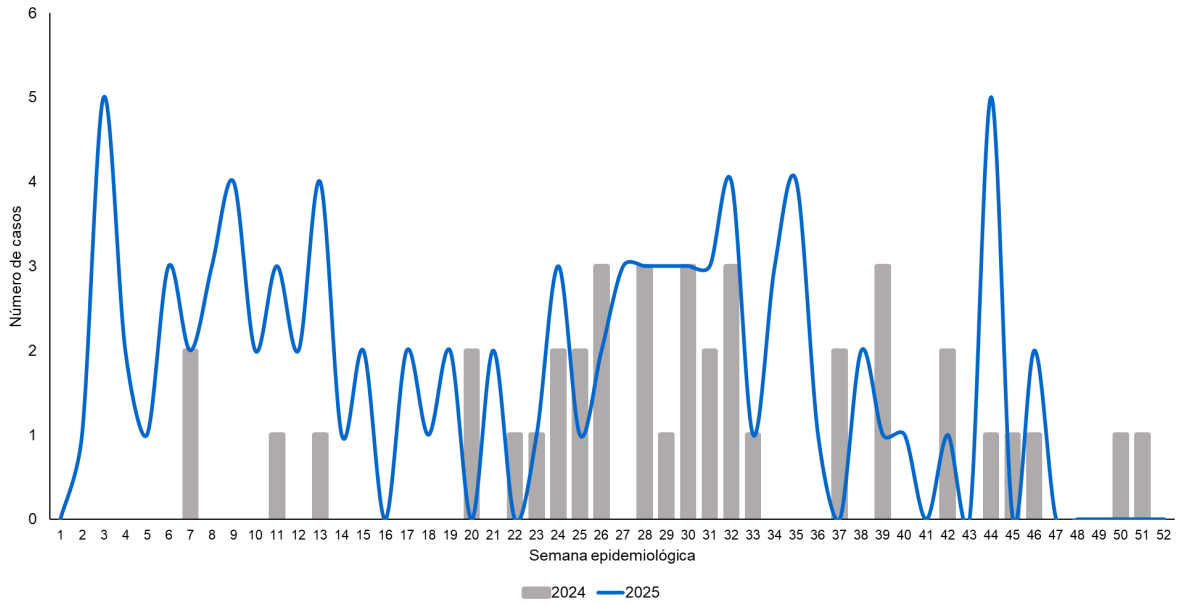


Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2025

En el gráfico 3, se presenta el comportamiento de esta enfermedad a nivel de las nueve regiones del Ministerio de Salud, siendo la región Huetar Caribe (17/89) la que presenta el mayor número de casos notificados.

En el gráfico 4 se puede observar el comportamiento de la miasis por gusano barrenador en humanos por SE 01 a 52 del 2024 y SE 01 a 48 del 2025, con un total de 89 casos confirmados por esta enfermedad para el 2025, siendo que para la SE 48 del 2024 se confirmaron 38 casos de miasis por gusano barrenador en el país.

Gráfico 4
Costa Rica: Casos notificados de miasis de gusano barrenador, según SE, de la SE 01 a la 52 del 2024 al corte de la SE 48 del 2025



Fuente: Subárea de Vigilancia Epidemiológica, CCSS / Dirección de Vigilancia de la Salud, MS, 2024 y 2025

Dado que la mosca continúa circulando en el territorio nacional y existe la declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria Epidémica para el control y erradicación de la enfermedad de Gusano Barrenador, Decreto Ejecutivo N° 44382–MAG (*Cochliomyia hominivorax*), es de suma importancia que, ante la identificación de un caso sospechoso en humanos, se realice la coordinación interinstitucional e intersectorial bajo el enfoque de **Una Sola Salud**, Ministerio de Salud-Ministerio de Agricultura y Ganadería-Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA)-Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) según corresponda, para identificar casos sospechosos en humanos y/o animales, y puedan ser atendidos de manera oportuna.

A continuación, se brinda algunas generalidades de prevención y control de esta enfermedad:

- Mantener higiene personal, lavarse las manos regularmente con agua y jabón.
- Control, tratamiento e higiene en lesiones en piel de acuerdo con la recomendación del médico tratante.
- Asistir al establecimiento de salud público o privado cuando presente síntomas asociados a la enfermedad, tales como: dolor, malestar y picazón en el sitio de la lesión, enrojecimiento de la piel, herida con secreción, sensación que se mueve y con frecuencia, se pueden observar huevecillos y/o larvas visibles en la lesión.
- Mantener vigilancia y control en el cuidado de los animales, realizando revisiones frecuentes, así como la curación de todas las heridas e informar a las autoridades de salud animal (SENASA-MAG y/o MINAE) sobre la aparición de animales con gusaneras para que reciban atención oportuna.